

FUNÇÃO	MENTE	CORPO	REDE
ABVD Katz (0-6) · Barthel (0-100)	Cognição MEEM (ajustar escolaridade); MoCA, relógio, fluência	Nutrição MAN ≥ 24 / 17-23,5 / < 17 ; peso, panturrilha < 31 cm	Suporte familiar APGAR: > 6 boa · 4-6 mod. · < 3 acentuada
AIVD (caem 1º) Lawton (9-27) · Pfeffer ≥ 6	Humor EGD/Yesavage-15: ≤ 5 / ≥ 7 / ≥ 11 . Depressão atípica	Visão/Audição Snellen; sussurro — corrigir antes de rotular cognição	Cuidador Sobrecarga (Zarit); rastrear abuso → acionar rede formal
Mobilidade/quedas TUG · SPPB · Tinetti. Queda = red flag		Continência · Sono · Boca Perguntar ativamente; higiene do sono antes de hipnótico	
		Medicamentos Polifarmácia ≥ 5 ; Beers/STOPP-START; cascata de prescrição	

PROCESSO

Rastrear (IVCF-20)



Confirmar (instrumento)



Intervir (plano)



Dx funcional global + fragilidade

AGA BREVE NO HOSPITAL DE TRANSIÇÃO — a janela perfeita

Paciente estabilizado + tempo + meta de alta. Avalia capacidade real; direciona reabilitação; planeja alta segura ($\downarrow$ reinternação); desprescrição; mede ganho (Barthel/Lawton entrada $\times$ saída).

EVIDÊNCIA & ARMADILHA

Evidência (forte): AGA $\uparrow$ chance de o idoso estar vivo e EM CASA (Cochrane, Ellis 2017) — desfecho = funcionalidade.

Armadilha: medir habilidade declarada e não o desempenho REAL (“quem faz?”).